



MINISTRE DE LA SANTE
PUBLIQUE, HYGIENE ET
PREVOYANCE SOCIALE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Centre des opérations d'urgences de sante publique

« COUSP-RDC »

Rapport de Situation de la Maladie à Virus Ebola/16^{ème} épidémie

SitRep MVE N° 022/MVE_16/2025

Pays/Province : **RDC/Kasaï**

Zone de Santé touchée : **BULAPE**

Date de rapportage : 27 septembre 2025

Date de publication : **28 Septembre 2025**



53

**Cas
Confirmés**



11

**Cas
probables**



31

**Décès
confirmés**



47,2 %

**Taux
d'occupation
des lits
confirmés**



60,0 %

**Taux
d'occupation
des lits
suspects**



8 130

**Doses de
vaccin
déployées**



3 816

**Personnes
vaccinés**

I. POINTS SAILLANTS

- Aucun cas confirmé n'a été rapporté pour la journée du 27/09/2025.
- Deux (2) patients ont été déclarés guéris et sortis du CTE/HGR Bulape.
- Lancement de la vaccination avec la stratégie géographique dans la ZS de Bulape avec 14 équipes dans les villages de Bulape, Ingongo, Mpianga, Bulape Com, Dikolo et Bambalaie.
- Ouverture de 3 nouveaux rings dans l'AS Bulape (Ring 21 autour du cas RDC-KAS-BLP-205 /Village Tshitekeshi ; Ring 22 autour du cas RDC-KAS-BLP-193/Quartier Secteur ; Ring 23 autour du cas RDC-KAS-BLP-207/localité Kalambo).

NARRATIF DU CAS INDEX (Contexte)



Le 20 août 2025, une femme enceinte de 34 ans a été admise au service de gynéco-obstétrique de l'HGR de Bulape, présentant la fièvre, la diarrhée sanglante, des vomissements hémorragiques et une anémie sévère. Elle est décédée quelques heures plus tard dans un tableau de défaillance multi viscérale. Dans les jours qui ont suivi, un technicien de laboratoire et une infirmière ayant été en contact avec la patiente ont manifesté les mêmes symptômes et sont également décédés. Entre les semaines épidémiologiques 34 et 36, treize cas ont été notifiés, dont huit décès, soit un taux de létalité de 62 %. L'épidémie a été officiellement déclarée à la suite de la confirmation de cinq cas positifs par l'INRB en date du 04 septembre 2025.

II. MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

- Aucun nouveau cas confirmé n'a été notifié au terme de la journée du 27/09/2025
- Depuis le début de l'épidémie, 64 cas (53 confirmés et 11 probables) dont 42 décès ont été rapportés dans la zone de santé de Bulape, soit une létalité globale de 65,6% (Tableau I).
- Aucun décès n'a été notifié parmi les confirmés.
- La létalité parmi les cas confirmés est de 58,5% (31 décès/53 cas confirmés).
- De plus, aucune nouvelle aire de santé n'a été touchée. Le nombre d'aires de santé ayant notifié au moins un cas confirmé ou probable de MVE depuis le début de l'épidémie demeure de 6 (28,6%) sur 21 que compte la ZS de Bulape (Tableau I ; Figure 2).

Tableau I : Répartition des cas et décès confirmés et probables de maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Bulape, au 27 septembre 2025

Aire de santé affectée*	Nouveau(x) cas confirmé(s)	Cumul des cas et décès				Cas durant les 21 derniers jours (du 06/09/2025 au 27/09/2025)		Nombre de jours sans nouveau cas notifié
		Confirmés	Décès confirmés	Létalité (%)	Probables	Confirmés	Probables	
Zone de santé de Bulape (6 aires de santé) : létalité globale 64,1% (64 cas dont 41 décès)								
Bambalaie	0	4	2	50,0%	0	4	0	7
Bulape	0	17	11	64,7%	8	17	8	1
Bulape com.	0	4	4	100,0%	1	4	1	7
Dikolo	0	24	14	58,3%	1	24	1	1
Ingongo	0	1	0	0,0%	0	1	0	14
Mpianga	0	3	0	0,0%	1	3	1	5

*Les cas et les décès sont répartis par aire de santé de détection et ces chiffres sont susceptibles de changer.

Les aires de santé de Bulape et de Dikolo regroupent la majorité des cas confirmés ainsi que des décès enregistrés. Depuis mai 2025, la situation épidémiologique reste stable.

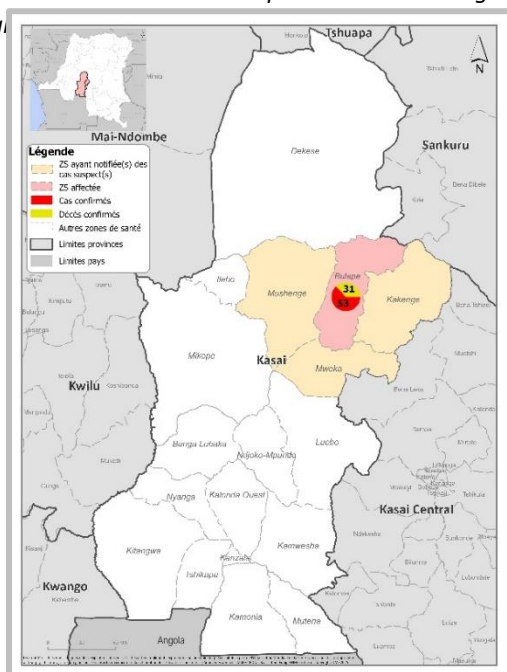


Fig1. Répartition géographique des zones de santé affectées par la MVE et celles à risque dans la province du Kasai, au 27 septembre

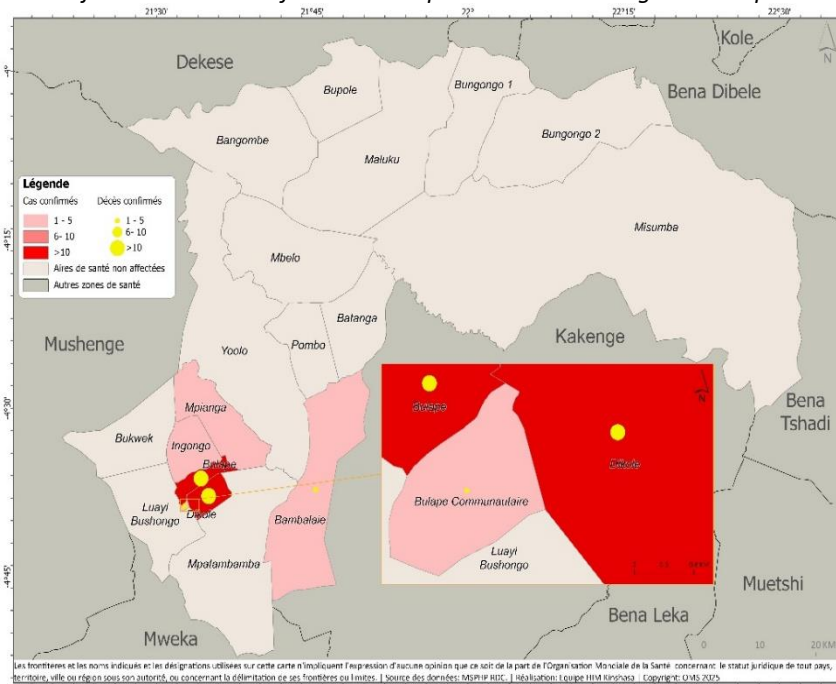


Fig2. Répartition géographique des cas et décès confirmés par Aires de Santé dans la ZS de Bulape au 27 Septembre 2025.

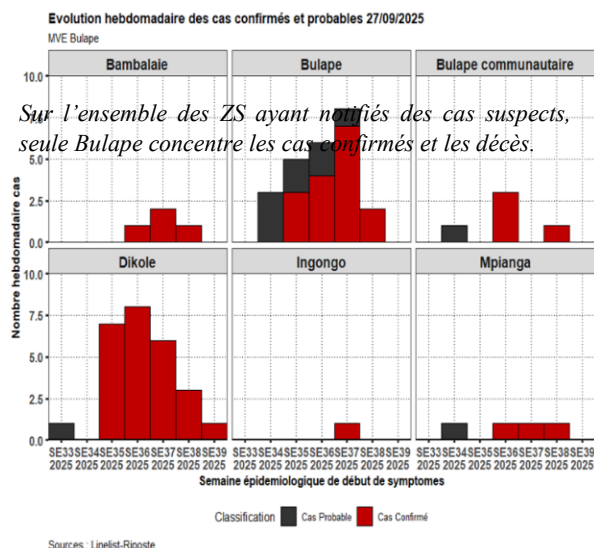


Fig 3. Evolution hebdomadaire des cas confirmés et probable par aire de santé au 27 septembre 2025 par début de symptôme.

Les AS de BULAPE et DIKOLE comme principaux foyers de l'épidémie dans la ZS de Bulape, il est à remarquer que de la SE35 à la SE36 Dikolo a notifié plus des cas tandis que de la SE37 à la SE 38, on note une hausse des cas confirmés dans l'AS de Bulape par rapport à Dikolo.

Dans la ZS de Bulape, Les aires de santé de Bulape et de Dikolo sont les plus touchées, concentrant à la fois un nombre élevé de cas confirmés et des décès. Ce sont les épicentres dans la ZS de Bulape.

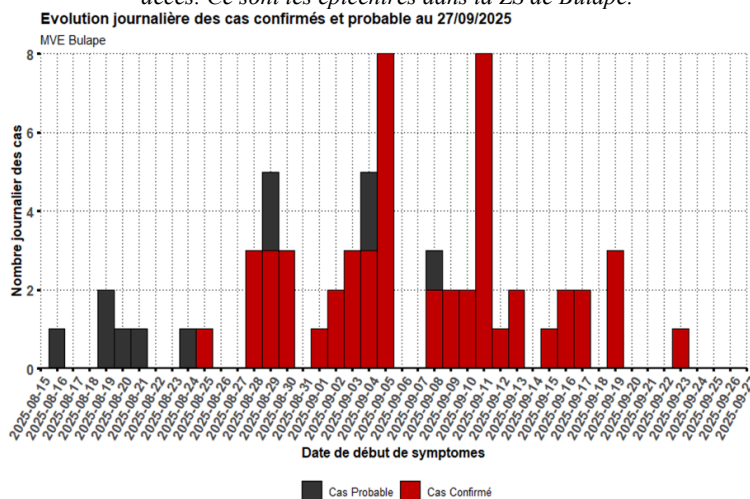


Fig 4. Evolution journalière des cas confirmés et probable au 27 septembre 2025 par début de symptôme .

Notification sporadique des cas depuis le 16 août 2025 avec trois clusters des cas.

Tableau 2. Répartition des alertes reçues, investiguées et validées par aire de santé, du 27 Septembre 2025

INDICATEURS	21/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	27/09/2025
Report alertes	2	5	6	6	7	6	6
Nouvelles alertes signalées du jour	24	29	14	24	31	26	20
Total alertes du jour	26	34	20	30	38	32	26
Alertes Validées du jour	19	13	14	12	10	15	7
Alertes investiguées du jour	23	29	14	28	38	32	7
Suspects prélevés	15	8	4	12	8	14	7
Transférés au CTE	15	8	3	12	10	14	7

NA : non applicable ; ND : non disponible

Au cours de 7 derniers jours (du 21 au 27/09/2025), le nombre moyen d'alertes notifiés journalièrement est de 29.

COORDINATION

- Tenue régulière des réunions de coordination du SGI avec le niveau opérationnel et stratégique.
- Réception des engins roulants et autres intrants de la riposte à travers les différents partenaires (ACDC, Unicef, etc.)
- Descente de terrain dans l'Aire de Santé (AS) Bambaiaie dans le cadre de suivi des recommandations de la mission antérieure et le désengorgement de la voie d'accès alternative de Bulape vers Bambaiaie (36 km).

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE (MÉDICALE, NUTRITIONNELLE & PSYCHOSOCIALE)

- Réalisation des investigations approfondies autour de cinq (5) derniers cas confirmés dans la ZS de Bulape.
- Pour la journée du 27/09/2025, les activités de la recherche active ont été réalisées au Poste de santé (PS) Bulape 3. Des 122 patients ayant consulté dans cet ESS au cours de 15 derniers jours, 54 alertes ont été remontées et devront être investiguées.
- Poursuite de la mise à jour des bases des données alertes, contacts, investigations.
- Poursuites des investigations et suivi des contacts dans les différentes aires de santé affectées de la zone de santé de Bulape.

Points sur la surveillance aux Points d'entrée et Points de Contrôles (PoE/PoC)

- Au total, 3 841 (99,8%) personnes ont été screenées parmi 3 850 passants pour la journée du 27/09/2025.
- Depuis le début des activités aux Points de Contrôles (PoC) en date du 13/09/2025, 49 398 personnes ont été enregistrés dont 47 600 (96,3%) screenées. Au total, 12 alertes ont été remontées dont 4 validées.
- De plus, 49 395 (99,9%) des toutes les personnes passant aux PoC ont été sensibilisées.

LABORATOIRE

- Un total de trente (30) échantillons ont été reçus (18 nouveaux suspects et 12 ré-prélèvements) pour la journée du 27/09/2025, et ont été analysés au laboratoire. Aucun de ces échantillons n'est revenu positif à la MVE. Jusqu'au 27/09/2025, 53 cas confirmés ont été diagnostiqués en laboratoire.
- Depuis le début de l'épidémie, 316 échantillons ont été reçus et analysés (100,0%) par le laboratoire.

Tableau 4. Synthèse de la situation des échantillons reçus et analysés au laboratoire au 27 septembre 2025

Indicateurs	Données
Échantillons reçus (total)	30
Nouveaux cas suspects	18
Re-prélèvements	12
Échantillons analysés	30
Ré-prélèvements analysés	12
Résultats des tests	
Échantillons de sang	
Cas confirmés du jour	0
Non-cas du jour	11
Total non-cas	195
Total des cas confirmés	53

Tableau 4. Situation des patients hospitalisés dans les centres de traitement Ebola (CTE), centre de transit (CT) ou assimilés en date du 27 septembre 2025

CI/CT/CTE	Cas suspects			Cas confirmés			Guéris	
	Nombre de lits	Nombre de cas	Taux d'occupation (%)	Nombre de lits	Nombre de cas	Taux d'occupation (%)	Guéris du jour	Cumul guéris
CTE HGR Bulape	29	15	51,7%	20	12	60,0%	0	9
CI Bambalaie	4	1	25,0%	NA	NA	0,0%	NA	NA
CT Ingongo	3	1	33,3%	NA	NA	0,0%	NA	NA
Total	36	17	47,2%	20	12	60,0%	0	9

NA : Non Applicable

- S'agissant de la journée du 27/09/2025, aucune nouvelle admission d'un patient confirmé n'a été signalé au CTE. Cependant, 7 nouveaux suspects y ont été acheminés.
- Ainsi, 29 malades sont en hospitalisation pour la journée du 27/09/2025. De tout l'effectif, 17 sont des cas suspects tandis que 12 sont confirmés à la MVE. Le taux d'occupation du bloc des suspects est de 47,2 % vs 60,0 % chez les confirmés. Au total, neuf (9) patients ont été déclarés guéris et déchargés du CTE.
- Depuis le début de l'épidémie, le traitement spécifique (Mab114) a été administré à 31 patients.

Activités phares du pilier

- Déchargement de deux (2) sorties guéris.
- Briefing des IT et ITA sur les ABCD des soins optimisés des cas de MVE.
- Préparation psychologique et psychoéducation aux 2 guéris.
- Finalisation des travaux de construction d'un nouveau CTE de Bulape et sera incessamment fonctionnel (mise en marche d'un générateur de 22 KVA pour la fourniture en électricité du CTE).

PREVENTION ET CONTRÔLE DE L'INFECTION (PCI/WASH)

- Réalisation de 4 EDS complets dont deux (2) au CTE HGR Bulape et deux (2) dans la communauté (1 EDS dans l'AS Mpata mbamba et 1 Bulape village Tshikapa).
- Décontamination systématique de 2/2 ménages du cas confirmé du 26 Septembre dans l'AS de Bulape Com.
- Décontamination de 5/5 ménages autour des cas suspects et briefing de 15 hygiénistes, dans la Zone de santé de Mushenge, dans l'AS Pilote.
- Renforcement et mise à niveau des superviseurs d'AS/ PCI.
- Clôture de la session de formation de 14 superviseurs, hygiénistes et prestataires de soins sur la MVE.

VACCINATION

- Lancement de la vaccination avec la stratégie géographique dans la ZS de Bulape avec 14 équipes dans les villages de Bulape, Ingongo, Mpianga, Bulape Com, Dikolo et Bambalaie.
- Ouverture de 3 nouveaux rings :
 - Ring 21 autour du cas RDC-KAS-BLP-205 (AS Bulape/Village Tshitekeshi).
 - Ring 22 autour du cas RDC-KAS-BLP-193 (AS Bulape/ Quartier Secteur).
 - Ring 23 autour du cas RDC-KAS-BLP-207 (AS Bulape/ localité Kalambo).
- Poursuite de la vaccination des PPL dans la ZS de Mweka.
- Situation des vaccins
 - Total doses reçues : 8 130

- *Nombre doses administrées : 3 816*
- *Solde vaccins en stock : 4 314*

COMMUNICATION SUR LES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

- *Plaidoyer mené auprès du Directeur de la province éducationnelle Kasai 2 à Mweka pour son implication dans les activités de riposte.*
- *Sensibilisation au Campement Katshibi et échanges avec le Chef de lotissement sur la prévention de la MVE.*
- *Sensibilisation au ring de vaccination au quartier Tshitekeshi et Bena Mudimu dans les AS Bulape et Dikolo.*
- *Entretien avec les religieux, chefs coutumiers et chefs d'établissement dans les AS de Bulape, Bulape Com Dikolo et Mpatambamba.*

SECURITE

- *Monitoring sécuritaire quotidien.*

LOGISTIQUE

- *Déploiement de 04 motos et 11 véhicules sur le terrain avec les équipes des différents piliers.*
- *Suivi des travaux de remontée d'eau vers l'HGR Bulape.*
- *Réception de 10 motos (donation UNICEF).*
- *Réception d'un kit Starlink (donation CDC).*
- *Réception de la tuyauterie pour les travaux d'adduction d'eau (OMS).*
- *Réception d'EPI (PPE).*

III. DEFIS ET GAPS

- *Besoin en staff, matériels et réactifs additionnels pour installer un laboratoire de diagnostic de la MVE à Mweka et à Tshikapa.*
- *Insuffisance d'intrants et matériels adaptés pour la prise en charge.*
- *Insuffisance en psychologues cliniciens.*
- *Faible prise en charge nutritionnelle au niveau du CTE.*
- *Insuffisance d'ambulances pour l'acheminement rapide des patients vers les structures dédiées.*
- *Besoin urgent d'un GeneXpert 4 modules pour Mweka.*

IV. PERSPECTIVES

- *Effectuer un suivi pour l'installation des laboratoires de diagnostic de la MVE à Mweka et Tshikapa.*
- *Déployer rapidement les psychologues cliniciens afin de mieux couvrir cette thématique dans le cadre la réponse à la MVE.*
- *Faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour accélérer la mise à dispositions des fonds alloués à la réponse.*
- *Déployer les ressources humaines additionnelles pour renforcer les différents piliers de la réponse (+++ Surveillance et gestion des données.*

Photos des activités de terrain



Dotation d'un KIT Starlink par Africa CDC



Dotation des motos à l'équipe de la Riposte par UNICEF

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter

Pour l'Institut National de Santé Publique (INSP) de la RDC

Le Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

Tel. : +243 816 040 145

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Le Coordonnateur COU-SP

Prof NGANDU Christian

Tél. : +243998091915

E-mail : christian.ngandu@insp.cd

L'Incident Manager SGI MVE Epi16

Dr. KITENGE OMASUMBU Richard

E-mail : richard.kitenge@insp.cd

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS/RDC)

Le Représentant ai de l'OMS en RDC

Dr ELOVAINIO Riku Edward

E-mail : elovainior@who.int

Incident Manager de l'OMS dans la réponse MVE

Dr Mory Keita

E-mail: mokeita@who.int

Le Team Lead Cluster EPR de l'OMS en RDC

Dr Mouctar Diallo

E-mail : dialloam@who.int

